# 21 世纪的语用障碍研究[①]

露易丝·卡明斯[②]
邹　润[③]

**摘要**：本文回顾了迄今为止临床语用学研究所取得的进展，并探讨了 21 世纪临床语用学的发展方向：①关注伴有复杂神经认知和精神疾病的语用障碍病例，如妥瑞氏综合征儿童；②关注遭受社会边缘化或排斥的福利院儿童、监狱中犯人以及有药物成瘾或其他成瘾行为群体的语用障碍问题；③临床语用学的语用特征可以在除原发性语用障碍之外的其他疾病的诊断中发挥作用，用于评估及诊断精神、认知和行为障碍。

**关键词**：临床语言学；复杂患者群体；成瘾行为；社会边缘化；语用特征

## Pragmatic Disorder in the Twenty-first Century

Louise Cummings
Translated by ZOU Run

**Abstract:** The present paper provides a comprehensive review of the progress achieved thus far in clinical pragmatics research to date and delves into the prospective avenues for development in the 21st century. These avenues encompass: ①a heightened emphasis on the clinical population afflicted with complex neurocognitive and neuropsychiatric problems, such as individuals with Tourette syndrome who exhibit pragmatic impairments; ②a deliberate consideration of children residing in institutional care, incarcerated adults, and individuals grappling with substance abuse disorders and

---

① 本文原载于 Louise Cummings 主编的《语用障碍：复杂且未受重视的群体》(2021 年版)(*Handbook of Pragmatic Language Disorders*：*Complex and Underserved Populations*)第一章(第 1—22 页)。

② 露易丝·卡明斯，原文作者，香港理工大学英语与传播系教授，英国皇家言语语言治疗师协会和健康与护理专业理事会成员，研究方向：语用学、临床语言学。著作包括《临床语用学》(2009)、《沟通障碍》(2014)、《语用障碍》(2014)、《剑桥沟通障碍手册》(2014)、《沟通障碍案例研究》(2016)、《临床语用学研究》(2017)和《言语语言疗法：入门》(2018)等。

③ 邹润，译者。博士，南方医科大学外国语学院副教授，研究方向：外语教育技术与评估、语言障碍、语言障碍测试。



中国知网　https://www.cnki.net

other forms of addiction, who may face social marginalization and exclusion; ③ an emerging role for pragmatic language features in the diagnosis of ailments beyond primary pragmatic disorders.

**Key words:** clinical pragmatics; complex clinical populations; addiction behavior; social marginalization; pragmatic language features

## 一 引言

对于临床语用学而言，21 世纪是一个不同寻常的起点。患有语用障碍的儿童和成人每天要在纷繁芜杂的世界里应对数以百万计的语言信息和社交信号。他们在惴惴不安的早晨中醒来，不确定自己是否具备足够的能力来应对一天的沟通交往。儿童患有语用障碍，仍然渴望融入同伴的游戏和活动，希望得到理解和接纳，而不是遭受误解与排斥。他们希望老师能够认识到他们的交流难题，不将其误认为是孤僻的性格、不恰当的行为，甚至是故意的挑衅。这些孩子需要学会如何向餐厅服务员明确表达自己对食物的偏好，如何在课堂上向老师提出去洗手间的请求。在课堂上被要求读故事或回答问题时，他们常常感到焦虑，因为老师担心他们不能理解上课内容。成人患有语用障碍同样面临不少挑战。他们可能害怕在会议中发言或进行演示时出现尴尬，担心自己的表现显得不自然。在社交场合，如接受或婉拒朋友的生日派对邀请、午餐时与同事进行轻松交谈，或者表达对同事提供顺风车帮助的感激之情，这些对他们来说都是难题。他们也担心可能会误解部门经理发出的电子邮件内容，从而做出不恰当的回复。

患有语用障碍的儿童和成人常常受到各种焦虑的困扰，其中包括但不限于上述提及的问题。即使是那些还未意识到自身存在语用困难的儿童与成人，他们也常常在日常言语交流中体验各种挫败感。这些困扰不仅影响了儿童的学业成绩和成年人的职业发展，也对所有年龄段的个体社会功能产生了影响①。语用障碍还与抑郁症、焦虑症等心理疾病有关，尤其与年轻

① Cummings, L. *Pragmatic disorders*. Springer, 2014. Snow, P., Douglas, J. "Psychosocial aspects of pragmatic disorders". In L. Cummings (Ed.), *Research in clinical pragmatics (Perspectives in pragmatics, philosophy & psychology)* (Vol. 11, pp. 617 - 649). Springer International Publishing AG, 2017.



中国知网 https://www.cnki.net

男性的越轨行为有关。通过及时、有效的临床言语治疗,这些症状即使不能全部根治,也能达到一定程度的缓解效果。然而,那些已确诊为语用障碍却无法获得治疗,或者未被明确诊断,又或无明显病症的人又该如何应对呢?这是治疗语用障碍的临床医生所面临的核心挑战。面对挑战,首先要考虑的是关注迄今为止被临床言语治疗忽视的临床人群。这些人群中的个体可能具有复杂的神经认知和精神类疾病,而这些问题应由语言病理学家以外的专业人员进行评估和治疗。此外,社会排斥和文化无法融合等因素也限制了这些人群获得言语治疗的机会。本文将重点讨论这部分被忽视的临床人群。

本文讨论的重点内容如下。

(1) 回顾迄今为止临床语用学研究领域中取得的进展和不足。虽然临床语用学领域产出了大量的实证研究成果,但并非所有的研究发现都能有助于更深入地理解语用障碍,这其中的原因值得我们深思和探索。

(2) 关注非典型性病例。他们往往同时伴有复杂的神经认知和精神疾病。尽管评估和治疗通常由非语言病理学专家进行,但考虑到他们的问题与语言使用密切相关,尤其在语用方面,他们也迫切需要专业的语言病理学干预。我们不应该将这些患者孤立起来,忽视他们在语用方面的未满足需求。

(3) 关注福利院的儿童、监狱中的成年人和患有药物成瘾或其他成瘾行为的群体。这些群体常常面临社会的排斥和偏见,并且在语言病理服务方面缺乏足够的关注和支持。尽管患有孤独症谱系障碍的儿童可以通过诊所的儿科和精神科医生获得转诊,并接受言语治疗,但由于医院转诊程序的限制,像妥瑞氏综合征患者这样的群体(表现为反复、半自发的动作和声音抽搐)即便存在严重的语用障碍,也可能无法被引荐到语言病理学家那里进行诊断①。语言病理学专家和医生未能主动向儿科和精神科医生强调这些儿童及成人急需临床言语治疗的重要性也是一个问题。此外,语言病理学家可能缺乏评估和诊断非传统患者群体(如监狱中的囚犯)所需的

① Eddy, C.M., Mitchell, I.J., Beck, S.R., Cavanna, A.E., & RICKARDS, H.E. "Impaired comprehension of nonliteral language in Tourette syndrome". *Cognitive and Behavioral Neurology*, 2010, 23(3): 178 - 184.



中国知网 https://www.cnki.net

专业知识和培训。只有深入理解这些复杂情况的根本原因，我们才能为这些特殊群体提供恰当的语用支持，并为临床语用学的进一步发展打下坚实的基础。

(4) 语用特征被应用到不同非典型性语用障碍的诊断中，并扩展到新的应用领域(如识别社会交流障碍等原发性语用障碍)，是临床语用学未来发展的关键方向，也是其持续发展的驱动力。例如，将语用特征运用于痴呆症和精神分裂症的诊断①，标志着临床语用学在疾病学和诊断学领域的一个新起点。鉴于多种类型的痴呆症在早期阶段症状极为相似，并且在没有非侵入性生物标志物的情况下，医生在确诊方面面临困难②。因此，利用语用特征来帮助疑似痴呆症患者的诊断显得尤为重要。鉴于此，语用能力损伤有可能成为痴呆症诊断的行为标志。

## 二 临床语用学：研究现状

在过去四十年里，语用障碍研究发展迅速。早期的研究中，只有少数学者关注了语用能力损伤儿童③和成人失语症患者④的言语行为，其中以请求言语行为为主。随后，越来越多的学者开始对言语行为、会话含义、预设、指示语、语境、非字面意义和修辞性语言等语用概念进行临床研究(Cummings 对其进行了系统综述⑤)。这些研究结果加深了临床医生和研究人员对语用功能的理解。例如，有研究结果表明，语用能力和语言结构是可分割

① Cummings, L. "Establishing diagnostic criteria: The role of clinical pragmatics". *Lodz Papers in Pragmatics*, 2012, 8(1): 61 - 84.

② Reilly, J., Rodriguez, A. D., Lamy, M., Neils-strunjas, J. "Cognition, language and clinical pathological features of non-Alzheimer's dementias: An overview". *Journal of Communication Disorders*, 2010, 43(5): 438 - 452.

③ Rom, A., & BLISS, L. S. "The use of nonverbal pragmatic behaviors by language-impaired and normal-speaking children". *Journal of Communication Disorders*, 1983, 16(4): 251 - 256. Prinz, P. M. "An investigation of the comprehension and production of requests in normal and language-disordered children". *Journal of Communication Disorders*, 1982, 15(2): 75 - 93.

④ Wilcox, M. J., Davis, G. A. "Speech act analysis of aphasic communication in individual and group settings". In *Proceedings of the clinical aphasiology conference* (pp. 166 - 174). BRK Publishers, 1977. Hirst, W., Ledoux, J., Stein, S. "Constraints on the processing of indirect speech acts: Evidence from aphasiology". *Brain and Language*, 1984, 23(1): 26 - 33.

⑤ Cummings, L. *Clinical pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. Cummings, L. *Pragmatic disorders*. Dordrecht: Springer, 2014.



中国知网 https://www.cnki.net

的。非流利性失语症成年患者产出的话语结构性差(如语法结构简化),但依然能使用足够的实词实现有效交流。然而,一个患有语用能力损伤(或社交语用交流障碍)的孩子或许能够说出流利且结构良好的语言,却难以与人正常交谈或叙述故事。另有研究结果表明,成人失语症患者在治疗后可以提高语言结构的正确性,但并不一定能改善其语用交际能力①;早期痴呆症患者的语音和句法系统尚表现为正常,但其语用能力已经部分受损②。这些发现都表明,语用能力是大脑认知能力中非常特殊的组成部分③。然而,可分割的能力并不意味着这种能力可以完全脱离语言结构而存在,因为某些语言结构仍然承担着言语行为、会话预设等语用功能。患有语法缺失失语症的成年人无法使用倒装结构(如 Can you close that window?)来表达请求的间接言语行为,他们同样也无法使用有定名词短语、分裂句型和叙述动词等词汇和语法结构手段来表达会话预设功能。例如:

例 1:The house on the hill is expensive.此句的定名词短语"the house on the hill"预设的内容是"山上有一座房子"(There is a house on the hill)。

例 2:It was the boy who broke the window.该分裂句型中"it was the boy"预设的内容是"有一个人打破了窗户玻璃"(Someone broke the window)。

例 3:Joan regretted leaving her job.这句话中的叙述动词"regret"预设的内容是"琼离职了"(Joan left her job)。

大量的临床语言研究结果都证实了多数语用功能与产出和理解句法和语义结构的能力之间存在着错综复杂的关系。例如,Katsos④ 等发现,患有特定型语言障碍的儿童在理解含有"all(全部)"和"some(一些)"等量化表达的语句时存在困难。当这些儿童与年龄较小、正常发育的儿童一同进行语

① Coelho, C.A., & Flewellyn, L. "Longitudinal assessment of coherence in an adult with fluent aphasia. *Aphasiology*", 2003,17(2): 173 - 182.

② Cummings, L. *Language in dementia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

③ Cummings, L. *Clinical pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. Cummings, L. *Pragmatic disorders*. Dordrecht: Springer, 2014.

④ Katsos, N., Roqueta, C.A., Estevan, R.A.C., Cummins, C. "Are children with specific language impairment competent with the pragmatics and logic of quantification?" *Cognition*, 2011,119(1):43 - 57.



中国知网 https://www.cnki.net

法理解测试时，他们面临的困难与后者相似。研究结果揭示了特定型语言障碍儿童在运用语用信息量原则方面遇到的挑战，与他们整体的语言障碍一致。此发现进一步证实了语用能力和语法能力之间的紧密联系，并反驳了其他研究者认为两者可完全分离的观点。

如果临床语用学研究为探索语用学与语言学交汇点的研究提供了可能，那么它也同时开辟了另一个同样重要的研究领域——语用学与认知科学的结合。近年来，研究者开展了大量研究，探讨语用学和心智理论之间的关系①。心智理论指的是个体对自己和他人心理状态的认知能力②。心理状态包括诸如知识和信仰等认知状态，以及快乐和悲伤等情感状态。心智理论赋予我们能力去预测和解释他人的行为，也包括交流中言语和非言语的反应。我们运用心智理论理解发问者说“你知道现在几点了吗?”的真实意图。在这种情况下，发问者的目的是得到当前时间的信息，因为他们自己不了解。因此，发问者的交际意图可以被理解为他们想要获取他们目前不知道的信息。但有时，说话者会故意表达出反常的交际意图来达到讽刺的效果，例如：Your lack of generosity is so endearing(你缺乏慷慨大方的品质真是太迷人了)。显然，说话者并不认为对方吝啬是迷人的特质，而是通过讽喻向对方传递一个含蓄的信息。可见，理解这种讽喻也需要听者运用心智理论来揭示说话者的真实意图。

心智理论已被证明是理解儿童和成人语用障碍有价值的解释性理论。研究表明，患有孤独症谱系障碍、精神分裂症和痴呆症等疾病的患者在心智

---

① Cummings, L. “Clinical pragmatics and theory of mind”. In A. Capone, F. Lo Piparo, M. Carapezza (Eds.), *Perspectives on linguistic pragmatics* (Perspectives in pragmatics, philosophy & psychology) (Vol. 2, pp. 23 - 56). Cham, Switzerland: Springer, 2013. Cummings, L. “Pragmatic disorders and theory of mind”. In L. Cummings (Ed.), *Cambridge handbook of communication disorders* (pp. 559 - 577). Cambridge: Cambridge University Press, 2014. Cummings, L. Theory of mind in utterance interpretation: The case from clinical pragmatics. *Frontiers in Psychology*, 2015:01286Cummings, L. “Cognitive aspects of pragmatic disorders”. In L. Cummings (Ed.), *Research in clinical pragmatics* (Perspectives in pragmatics, philosophy & psychology) (Vol. 11, pp. 587 - 616). Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2017.

② Premack, D., Woodruff, G. Does the chimpanzee have theory of mind? *Behavioral and Brain Sciences*, 1978, 1(4):515 - 526.



中国知网 https://www.cnki.net

理论和语用能力方面存在相互关联的障碍①。此外,研究还表明,语用障碍患者在不同的语用技能方面面临着不同程度的挑战。例如,阿尔茨海默病患者理解讽喻或反语的能力急剧恶化,速度超过了理解隐喻的能力②。其原因是理解讽喻需要运用二阶心智理论(即能够理解说话者针对另一个人的心理状态)③,而隐喻的理解只需要一阶心智理论参与(即将说话者的心理状态与其对世界的看法联系起来)。心智理论与语用学之间的关系不可能是简单的因果关系,因为在某些情况下,这两者的关系还需要通过执行功能(如工作记忆)来调节④。

儿童发展性语用障碍也可以用心智理论来解释。例如,孤独症谱系障碍儿童在掌握语用知识和理解语言的非字面含义方面往往进展较慢,这表明他们心智能力成熟方面出现延迟⑤。这些研究以及其他未提及的研究都表明,心智理论具有广泛的应用性,有助于我们理解儿童和成人在各种语用障碍上的差异。

心智理论只是语用障碍认知基础的一个组成部分⑥。临床语用学研究关注语用障碍与执行功能之间的关系。执行功能包括以目标为导向的计划、执行和监控行为⑦。执行功能的关键内容包括计划能力、组织能力、抑

---

① Losh, M., Martin, G. E., Klusek, J., Hogan-brown, A. L., & SIDERIS, J. "Social communication and theory of mind in boys with autism and fragile X syndrome". *Frontiers in Psychology*. Fukuhara, K., Ogawa, Y., Tanaka, H., Nagata, Y., Nishida, S., Haga, D., Nishikawa, T. "Impaired interpretation of others' behavior is associated with difficulties in recognizing pragmatic language in patients with schizophrenia". *Journal of Psycholinguistic Research*, 2017,46(5):1309-1318.

② Maki, Y., Yamaguchi, T., Koeda, T., & Yamaguchi, H. "Communicative competence in Alzheimer's disease: Metaphor and sarcasm comprehension". *American Journal of Alzheimer's Disease and Other Dementias*, 2013,28(1):69-74.

③ Winner, E., Leekam, S. "Distinguishing irony from deception: Understanding the speaker's second-order intention". *British Journal of Developmental Psychology*, 1997,9(2):257-270.

④ Honan, C. A., Mcdonald, S., Gowland, A., Fisher, A., Randall, R. K. "Deficits in comprehension of speech acts after TBI: The role of theory of mind and executive function". *Brain and Language*, 2015,(150):69-79.

⑤ Whyte, E. M., Nelson, K. E. "Trajectories of pragmatic and nonliteral language development in children with autism spectrum disorders". *Journal of Communication Disorders*, 2015,(54):2-14.

⑥ Bosco, F. M., Tirassa, M., Gabbatore, I. "Why pragmatics and theory of mind do not (completely) overlap". *Frontiers in Psychology*, 9,1453.

⑦ Diamond, A. "Executive functions". *Annual Review of Psychology*, 2013,64:135-168.



中国知网 https://www.cnki.net

制控制能力、工作记忆以及注意力。临床医生已经观察到，创伤性脑损伤患者的语用障碍与执行功能缺陷密切相关①。现在越来越多的研究表明，执行功能障碍也与其他神经退行性疾病成人患者②以及右侧大脑半球损伤患者③的沟通障碍有关（读者还可参看 Feyereisen 等④和 McDonald⑤ 对于这些人群的执行功能与语用能力关系的不同观点）。临床语用学的研究推动了我们对于语言病理学家提出的“认知-沟通障碍”背后执行功能基础的理解。许多认知-沟通障碍患者在信息管理方面受到损害，这可能导致他们在交流中出现信息省略、重复或无法逻辑性地组织，甚至可能涉及错误或不相关的信息。现在的研究表明，这些困难都与执行功能的缺陷有关⑥。还有研究表明，话语连贯性不足的根本原因也是执行功能的缺陷⑦。随着这一领域研究的持续深入，我们将更深入地理解语用障碍与执行功能之间的关系。

将语用障碍置于认知框架中进行描述的价值在于提供了一个解释性模型，有助于我们更深入地理解这些障碍。尽管早期的临床语用学研究积累了大量实证数据，但由于缺乏这种解释性框架，这些研究结果未能充分揭示

---

① Douglas, J. M. “Relation of executive functioning to pragmatic outcome following severe traumatic brain injury”. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 2010, 53(2), 365 - 382.

② Bambini, V., Arcara, G., Martinelli, I., Bernini, S., Alvisi, E., Moro, A., Cappa, S.F., Ceroni, M. “Communication and pragmatic breakdowns in amyotrophic lateral sclerosis patients”. *Brain and Language*, 2016, 153 - 154: 1 - 12. Cummings, L. *Language in dementia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

③ Saldert, C., Ahlsén, E. “Inference in right hemisphere damaged individuals' comprehension: The role of sustained attention”. *Clinical Linguistics & Phonetics*, 2007, 21(8): 637 - 655. Cummings, L. “Describing the Cookie Theft picture: Sources of breakdown in Alzheimer's dementia”. *Pragmatics & Society*, 2019, 10(2): 151 - 174.

④ Feyereisen, P., BERREWAERTS, J., & HUPET, M. “Pragmatic skills in the early stages of Alzheimer's disease: An analysis by means of a referential communication task”. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 2007, 42(1): 1 - 17.

⑤ Mcdonald, S. “Exploring the cognitive basis of right-hemisphere pragmatic language disorders”. *Brain and Language*, 2000, 75(1): 82 - 107.

⑥ Ash, S., Mcmillan, C., Gross, R.G., Cook, P., Morgan, B., BollER, A., Dreyfuss, M., Siderowf, A., Grossman, M. *The organization of narrative discourse in Lewy body spectrum disorder. Brain and Language*, 2011, 119(1): 30 - 41.

⑦ Ellis, C., Crosson, B., Gonzalez Rothi, L.J., Okun, M.S., Rosenbek, J.C. “Narrative discourse cohesion in early stage Parkinson's disease”. *Journal of Parkinson's Disease*, 2015, 5(2): 403 - 411.



中国知网 https://www.cnki.net

语用障碍的核心本质[①]。虽然研究语用障碍儿童在叙事中不能恰当运用指代和其他衔接手段具有其价值,但若不借助语言学或认知理论来解释(例如阐释为何儿童患者无法在工作记忆中有效维持先行名词短语),研究成果就难以促进我们对儿童语用障碍的理解,也难以对言语疗法提供实质性指导。临床语用学研究已经广泛覆盖了语用学领域许多方面,然而仍未明确划出研究范围的边界,因为并非所有的交际行为都具备语用特征。理解说话人面部表情的交际意图是一项社会感知技能,它对语用理解产生一定影响,但这项技能并不具备语用性质。此外,一些临床语用学研究还存在误用会话含义、预设和语言行为等语用概念的现象[②]。简单地认识到说话者违反了某一合作准则,并不等同于理解了话语的隐含意义。然而,这却被错误地认为是临床研究开展的前提假设[③]。诚然,尽管存在不足和缺陷,临床语用学在相对较短的时期内取得了相当大的成就与进步。

## 三 复杂的患者群体

学科的兴起需要时间来确定其研究范围与定位,并在不断进步中探索新的应用和研究领域。创新的研究方法将支撑学科的未来发展,并确保它对从事该领域研究的每个人都具有意义。临床语用学正处在发展的新阶段:它推动我们了解孤独症谱系障碍、创伤性脑损伤和社会沟通障碍的儿童与成人患者等群体的语用能力状况,并将持续深入研究。临床语用学已准备好应对新的临床挑战,并跨越其传统的理论和实践范畴。这些新挑战首先来自患有语用障碍、却通常不能被转诊给语言病理学专家治疗的患者。未被转诊的原因可能有很多:一方面,为他们提供医疗或健康服务的专业人员可能没有意识到转诊的重要性;另一方面,当前接受治疗的症状或行为掩盖了他们的语用困难。当患者被转诊到语言病理学专科后,临床语用学又面临另外一个挑战:患者的语用障碍可能是由复杂的神经认知和精神疾病

① Cummings, L. "Clinical pragmatics: A field in search of phenomena?" *Language & Communication*, 2007, 27(4): 396 - 432.

② Cummings, L. *Clinical pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

③ Surian, L. "Are children with autism deaf to Gricean maxims?" *Cognitive Neuropsychiatry*, 1996, 1(1): 55 - 72.



中国知网 https://www.cnki.net

所致，确切原因尚不明确，导致语言治疗专业人士无法清晰描述患者的语用交流问题。以下将概述对临床语用学构成挑战的各类患者群体。

接受语言康复治疗的儿童和成人患者存在较大差异。语言病理学专家会综合考虑患者的年龄、教育水平、社会文化背景等因素。尽管这些患者具有差异性，但他们表现出的语言障碍症状却大多是相似的。语言病理学专家主要诊治失语症、特定型语言障碍以及运动性言语障碍，如构音障碍和言语失用症。而癫痫或妥瑞氏综合征患者语言沟通障碍的病例在临床上较为少见，甚至不曾出现过。这并不是因为这些障碍患病率较低，或者这些患者中几乎不存在语言沟通问题。在普通人群中，癫痫至少与发育性口吃一样普遍，癫痫患者的语言与语用障碍在临床研究中也有记录①。为了理解为什么某些患者的语言和语用障碍成为临床语用学研究的重点，我们需要探究为何其他病患的语言障碍没有得到足够的关注。这可能涉及以下因素。

(1) 对语用障碍的专业认知程度以及将患者转诊到语言病理学专科的必要性的理解。

(2) 对于表现出复杂行为的患者的语言障碍特征的准确识别。

(3) 对神经认知和神经精神疾病患者在语言能力方面受损程度的了解。

很多医疗或健康服务专业人员对语言障碍以及语言病理学专家的工作了解有限，这已经不是一个新观点。McCann② 等评估了 100 名医疗或健康服务专业人员对失语症的认识。结果显示，尽管这些专业人员比普通大众更了解失语症，但整体认知水平仍然有限。其中 68% 的受访者对失语症有基本了解，而只有 21% 的人具备较深入的相关知识。在一项关于全科医生的研究中，Nesbitt 和 Thompson③ 指出，医护人员对语言康复在帕金森病患

① Broeders, M., Geurts, H., Jennekens-Schinkel, A. "Pragmatic communication deficits in children with epilepsy". *International Journal of Language & Communication Disorders*, 2010, 45(5): 608 - 616. Debiais, S., Tuller, L., Barthez, M.-A., Monjauze, C., Khomsi, A., Praline, J., DE Toffol, B., Autret, A., Barthelemy, C., Hommet, C. "Epilepsy and language development: The continuous spike-waves during slow sleep syndrome". *Epilepsia*, 2007, 48(6): 1104 - 1110.

② Mccann, C., Tunnicliffe, K., Anderson, R. "Public awareness of aphasia in New Zealand". *Aphasiology*, 2013, 27(5): 568 - 580.

③ Nesbitt, R., Thompson, R. "Exploring interdisciplinary management of Parkinson's disease". *International Journal of Language & Communication Disorders*, 1995, 30(S1): 414.



中国知网 https://www.cnki.net

者治疗中的应用价值认识不足。这种对专业知识的缺乏和认识上的不足导致患者未能被及时推荐到语言病理专家处接受治疗。在这项研究中,18 名被转诊到语言病理专科治疗的患者中,只有一名患者是由全科医生转诊的。Keating 等人①的研究发现,由儿科医生将患者转诊到语言病理专科的比例与他们接受的语言发展与沟通障碍培训质量有关。如果医生对常见的沟通障碍了解不足,那么他们对语用障碍的了解也会相应地减少。很多患有语用障碍的人能够说出结构完整、含义清晰的句子,没有表现出明显的交流问题,如言语内容不具意义等,医疗和健康服务专业人员可能不会立刻察觉到他们的语用困难,因此也不会建议他们转诊到语言病理专家那里接受诊治。这些情况解释了为何许多有语用障碍的患者至今未得到语言病理专科医生的治疗。

要探析未及时转诊的原因,语言病理专家首先需要明确哪些医疗或健康服务专业人员可能会接诊到未确诊的语用障碍患者。通常,神经科医生会接诊癫痫和神经退行性疾病(无论是否伴有痴呆)等患者;患有遗传和其他综合征的儿童患者则由儿科医生主导的评估和治疗多学科团队接诊;临床心理学医生负责强迫症和反应性依恋障碍患者的治疗方案;而精神病医生、心理学专家以及教育专家则会评估和治疗破坏性行为障碍的儿童患者。语言病理学专科医生必须向这些医疗人员普及语用障碍的知识,以便他们能够及时将语用障碍患者转诊到语言病理科接受专业治疗。然而,这并非易事,因为即使是经验丰富的语言病理学专家也可能难以识别患者的语用障碍,特别是当语用障碍与其他行为问题同时存在时。因此,量表成为了帮助语言病理学专家以及其他专业医疗人员诊断患者是否患有语用障碍的有效工具。儿童语言与沟通评估量表②包含 70 个子项,旨在甄别患有沟通障碍的儿童是否也存在语用障碍。使用此评估量表以及类似的评估工具有助于提高将有语用障碍的患者转诊到语言病理科的比例和准确性。

准确诊断患者是否患有语用障碍是将其转诊到语言病理科的必要条

---

① Keating, D., Syrmis, M., Hamilton, L., Mcmahon, S. "Paediatricians: Referral rates and speech pathology waiting lists". *Journal of Pediatrics and Child Health*, 1998,34(5):451-455.

② Bishop, D. V. M. *Children's communication checklist-revised* (2nd ed.). London: Psychological Corporation, 2003.



中国知网 https://www.cnki.net

件。如果未能确诊语用障碍，患者复杂的行为问题会使诊断变得更为困难。例如，患有破坏性行为障碍的儿童可能会抵触医护人员的治疗，表现出易激怒、撒谎和偷窃等反社会行为。同样地，语用障碍患者可能无法遵循指令或理解“你能坐下吗？（Can you sit down?）”这样的请求，他们未执行指令的行为可能会被误解为故意对抗。对于医护人员来说，判断儿童的愤怒是源自破坏性行为障碍疾病本身，还是由于无法有效传达信息而感到挫败，是具有挑战性的任务。此外，破坏性行为障碍并不是唯一可能掩盖语用障碍的疾病。妥瑞氏综合征儿童与成人患者会表现出或简单或复杂的运动性抽动和声带抽动。尽管这些抽动并非语用障碍的特征，但它们确实会干扰交流，包括手势和语言交流。因此，如果妥瑞氏综合征患者同时患有语用障碍，语用障碍对言语和非言语交流的影响可能会因运动性抽动或声带抽动而被忽视。同样地，反应性依恋障碍儿童患者在社交互动中可能表现出情感压抑或行为上犹豫，这与由于缺乏成功沟通经验而出现回避和犹豫行为的语言障碍儿童相似。

对临床医生而言，区分语用障碍症状与其他疾病的行为特征是具有挑战性的。诊断语用障碍所需的特异性方法超出了医生对语用障碍和类似破坏性行为障碍临床症状的了解范围。因此，确保语用障碍患者不被漏诊的方法之一就是让语言病理学家、精神科医生和（或）心理学专家对患者进行联合临床评估。然而，这种联合评估在常规临床实践中并不常见。联合评估具有潜力，可以帮助医生更好地掌握患者的各类复杂行为，共同制订更有效的治疗方案。然而，要实施联合评估，就需要不同专业领域的医生能够理解和运用彼此领域的术语和操作框架。只有这样，才能确保联合评估顺利进行。因此，涉及的专业人员都需要接受综合性的教育。语言病理学专家应向精神病学和临床心理学的医生讲授有关语用障碍的知识。同时，精神科医生和心理学家也应向语言病理学家介绍诊断标准和使用的工具，以协助他们更准确地评估类似破坏性行为障碍和反应性依恋障碍的患者。只有通过跨学科专业团队的协作和共同努力，我们才能显著降低语用障碍的漏诊率和误诊率。

某些语言障碍患者没有成为语言病理学专科的显著案例，背后存在更深层的原因。多数患者在出现神经认知和神经精神功能紊乱后，才表现出



中国知网 https://www.cnki.net

语用障碍的症状。尽管语言病理学医生都接受过关于失语症和运动性语言障碍的神经解剖学和神经生理学的临床教育,但其中很少有人精通神经认知和神经精神障碍专业知识,以及了解这些紊乱对语言(尤其是语用能力)的影响。特别是像帕金森氏症这类神经退行性疾病,以及精神分裂症、破坏性行为障碍等精神疾病,它们所导致的语言障碍症状差异很大。

近年来,关于语言和沟通障碍的认知研究取得了显著进展,特别是对特定型语言障碍和发展性阅读障碍患者认知功能损害的关注日益增加①。此外,研究人员还深入探讨了心智理论缺陷如何影响孤独症谱系障碍患者的沟通能力,以及执行功能障碍如何影响创伤性脑损伤患者的沟通能力②。尽管如此,这些发现大多局限于语言病理学研究领域,并没有在临床实践中得到广泛应用。特别是在神经精神疾病的治疗领域,这个问题更为严重。Novak 和 Kapolnek③ 在一篇文章中提到,语言病理学尚未为精神病患者提供足够的临床治疗和研究支持。

> "一般来说,语言病理学医生不会为精神疾病患者提供临床言语治疗服务。此外,自 1995 年以来,《言语、语言与听觉研究》杂志上也没有发表过关于这个话题的文章"。

---

① Christo, C. "Developmental dyslexia". In L. Cummings (Ed.), *Cambridge handbook of communication disorders* (pp. 88 - 108). Cambridge: Cambridge University Press, 2014. Ellis Weismer, S. "Specific language impairment". In L. Cummings (Ed.), *Cambridge handbook of communication disorders* (pp. 73 - 87). Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

② Cummings, L. *Clinical pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. Cummings, L. "Clinical pragmatics and theory of mind". In A. Capone, F. Lo Piparo, & M. Carapezza (Eds.), *Perspectives on linguistic pragmatics* (Perspectives in pragmatics, philosophy & psychology) (Vol. 2, pp. 23 - 56). Cham, Switzerland: Springer, 2013. Cummings, L. *Pragmatic disorders*. Cham, Switzerland: Springer, 2014. Cummings, L. "Pragmatic disorders and theory of mind". In L. Cummings (Ed.), *Cambridge handbook of communication disorders* (pp. 559 - 577). Cambridge: Cambridge University Press, 2014. Cummings, L. "Cognitive aspects of pragmatic disorders". In L. Cummings (Ed.), *Research in clinical pragmatics* (Perspectives in pragmatics, philosophy & psychology) (Vol. 11, pp. 587 - 616). Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2017.

③ Novak, J. M., Kapolnek, K. M. "Speech-language pathologists serving clients with mental illness: A collaborative treatment approach". *Contemporary Issues in Communication Science and Disorders*, 2001, 28: 111 - 122.



中国知网 https://www.cnki.net

20 年前的观点至今仍然具有一定的正确性：语言病理学学位课程很少开设关于精神疾病患者沟通障碍的专业课程。《国际语言与沟通障碍》杂志在 2012 年 1 月至 2017 年 1 月期间仅发表了两篇关于心理健康问题的文章（一篇关于精神分裂症，一篇关于儿童情绪问题）。由于缺乏对临床疾病的专业培训，语言病理学专家往往难以将理论研究成果转化应用于临床实践，导致这些患者的交流需求未能得到优先考虑。因此，许多本可以接受语言治疗的语用障碍患者可能会被忽视，从而错失了从临床语言治疗服务中获益的机会。

## 四 未予重视的临床患者

其他群体的语用障碍同样无法得到语言病理学医生的专业治疗，但原因与上述情况截然不同。他们可能因为成瘾或犯罪行为而遭受社会边缘化和排斥，导致他们无法像其他人那样接受包括语言病理治疗在内的医疗保健服务。例如，生活在寄宿或寄养家庭中的儿童可能遭受来自亲生父母的身体忽视、情感忽视，以及他人的性侵犯。这些经历严重威胁了儿童的社会性和情感发展，进而影响他们的语言发展。儿童寄宿和寄养生活不稳定，频繁被不同照顾者多次安置。这种不连续照顾使得语言障碍和语用障碍难以被发现，也减少了被转诊至语言病理专科的可能性。因此，随着儿童寄养和寄宿机构和个人的增加，漏诊语用障碍的风险相应上升。此外，文化障碍也是这些患者无法接受临床语言治疗的另一原因。例如，被跨国收养的孩子可能患有语用障碍症，但他们的症状可能被视为文化适应困难，或被误解为处于不同文化背景下的“正常”语用表现。以下将详细讨论这些未得到足够关注的临床患者群体。

少年犯和被羁押人员面临着严重的语用障碍问题，这在很大程度上与监狱环境中其他疾病高发有关，如孤独症谱系障碍、智力残疾、精神分裂症、注意力缺陷多动障碍、创伤性脑损伤以及品行障碍①。对于已经患有这些疾病的少年犯和成年犯人而言，语用障碍进一步加剧了他们的困境。语用障

① Cummings, L. “Pragmatic disorders in forensic settings”. In F. Poggi & A. Capone (Eds.), *Pragmatics and law* (Perspectives in pragmatics, philosophy & psychology) (Vol. 10, pp. 349 - 377). Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2017.



中国知网 https://www.cnki.net

碍患者很难遵守针对犯人提供的教育改造指令。然而,这些教育改造至关重要,它们可以帮助犯人在离开监狱后重新融入社会,获得稳定工作,并减少重新犯罪的可能性。教育改造内容包括如何解决冲突、反思犯罪行为的深层原因和动机。这要求犯人具备较强的元语用意识和元认知能力,而这超出了许多犯人的语用能力范围。因此,语用障碍在一定程度上降低了犯人参与这些教育改造项目的积极性。鉴于此,对被羁押人员进行临床语言治疗以尽早识别和诊断他们的语用障碍显得尤为重要。遗憾的是,许多监狱中并不提供这种语言治疗服务。2016 年 10 月英国皇家语言治疗师协会向英国司法委员会提交关于监狱改革的书面调查报告,其中指出:

> "监狱中的在押人员对语言沟通有迫切需求。然而,他们可能无法获得有效的语言治疗和康复服务,这将导致他们无法参与教育改造。造成这一问题的原因可能包括对囚犯语言沟通需求的误解或忽视、监狱工作人员缺乏有关语言障碍识别和治疗的培训,以及监狱系统本身缺乏提供这些服务的足够资源和能力。"

根据 Clark 等人①的研究,整个苏格兰刑事司法系统仅提供每周 21 小时的语言治疗专项服务。如果监狱服刑人员无法获得与整个社会相匹配的语言治疗服务,监狱和其他惩教机构要成功实施教育改造计划将会面临极大困难。因此,在为囚犯提供任何临床语言康复服务时,语用技能的训练都是至关重要的一环。

即便某些犯人确实接受了临床语言康复治疗,他们患有的复杂精神类疾病也可能导致他们无法听从治疗指令。此外,监狱服刑人员中患药物使用障碍症和酒精使用障碍症的比例较高。Fazel 等人②对 24 项研究的 18388 名犯人进行了系统性回顾研究,结果表明新入狱的男性和女性囚犯中,约有

---

① Clark, A., Barrow, E., Hartley, K. "Unmet need in Scotland's criminal justice system". *Bulletin*, 2012,718:20-21.

② Fazel, S., Yoon, I. A., Hayes, A. J. "Substance use disorders in prisoners: An updated systematic review and meta-regression analysis in recently incarcerated men and women". *Addiction*, 2017,112(10):1725-1739.



中国知网 https://www.cnki.net

四分之一患有酒精使用障碍症，而男性犯人的药物使用障碍患病率同样居高不下，女性犯人则更高。酒精和药物成瘾现象在普通社区中也较为常见①。酒精和药物使用障碍是影响语用能力的危险因素，同时也降低了患者在语用干预治疗中的配合度。这可能是因为滥用酒精和药物损害了患者的心智理论②。一般而言，心智理论受损的人往往难以理解他人的意图和情感，这也可能导致他们无法理解说话人的交际意图。反过来，语用障碍似乎也会加剧酒精和药物使用障碍症状。Najam 等人③对 135 名受试者的语言能力进行了研究。这些受试者的父亲被诊断为药物使用障碍患者，因此他们被认为是药物滥用高风险受试者。研究者将年龄在 10 至 12 周岁和 16 周岁的药物滥用高风险受试者与 208 名药物滥用风险较低的儿童进行了比较研究，后者的父亲没有精神类疾病或药物使用障碍症状。研究结果发现，高风险受试者在语言能力测试④中的语用能力子项目的得分显著低于药物滥用风险低的受试者。具体而言，语言能力测试评估了受试者对歧义句意义辨析、隐喻理解以及意图表达的能力。16 周岁高风险受试者在理解歧义句和表达意图能力方面明显不如同龄组的低风险受试。Najam 等人③认为："语言能力受损的患者，特别是对抽象信息的理解能力受损，更容易患上药物使用障碍症。"无论酒精使用障碍和药物使用障碍是不是语用障碍的独立危险因素，或者语用障碍是否增加了患酒精和药物使用障碍的风险，或者两者是否都是与心智理论等第三变量相关，可以确定的是，与其他

① Arria, A.M., Caldeira, K.M., Allen, H.K., Bugbee, B.A., Vincent, K.B., O'grady, K.E. "Prevalence and incidence of drug use among college students: An 8-year longitudinal analysis". *American Journal of Drug and Alcohol Abuse*, 2017, 12:1-8. Krill, P.R., Johnson, R., Albert, L. "The prevalence of substance use and other mental health concerns among American attorneys". *Journal of Addiction Medicine*, 2016, 10(1):46-52.

② Kim, Y.T., Kwon, D.H., Chang, Y. "Impairments of facial emotion recognition and theory of mind in methamphetamine abusers". *Psychiatry Research*, 2011, 186(1):80-84. Onuoha, R.C., Quintana, D.S., Lyvers, M., Guastella, A.J. "A meta-analysis of theory of mind in alcohol use disorders". *Alcohol and Alcoholism*, 2016, 51(4):410-415.

③ Najam, N., Tarter, R.E., Kirisci, L. "Language deficits in children at high risk for drug abuse". *Journal of Child & Adolescent Substance Abuse*, 1997, 6(2):69-80.

④ Wiig, E.H., Secord, W. *Test of language competence-expanded edition*. London: The Psychological Corporation, 1989.



中国知网 https://www.cnki.net

人群相比,有成瘾疾病的患者无法获得同等程度的医疗保健服务①,这包括语言病理专科提供的临床语言治疗。为了成功解决药物和酒精成瘾问题,社区延伸服务项目必须努力满足这些人的身心健康需求。如果他们的语言与沟通障碍得不到治疗,他们将难以重新融入社会、获得就业机会,并参与成瘾者康复治疗计划。过去,语言病理学已经成功调整了其治疗范围以满足患者的需求,现在它同样需要调整以满足酒精和药物使用障碍患者的语言和沟通需求。

监狱中的囚犯、酒精和药物使用障碍患者并不是唯一被边缘化且未被诊断出患有语用障碍的群体。寄宿或寄养的儿童也可能患有未被发现的语用障碍,这可能严重影响他们的社会功能和学业成就②。这些儿童的语用障碍被忽视的原因有很多,其中一个重要原因是负责监护工作的部门很少将语用障碍儿童转诊到语言病理专科。Clark 和 Fitzsimons③ 的调查发现,在过去五年中,苏格兰某医疗保健信托的儿科语言治疗中心仅接收了 14 名由当地社会服务机构转诊的患者,这一数字仅占同期总转诊人数的 0.13%。这种低转诊率可能是由于社会工作者缺乏专业知识和培训,无法识别儿童的语用障碍。此外,社会工作者还需要优先考虑其他工作与职责,如妥善安置有复杂社会需求和情感需求的寄宿和寄养儿童,因此语言和沟通障碍的问题往往被搁置。

另一个导致儿童语用障碍被忽视的原因与他们的家庭背景有关。在进入社会工作部门的视野之前,这些儿童往往在混乱的家庭环境中与亲生父母生活了一段时间。亲生父母可能未配合健康巡视员对 0～5 岁的儿童进行生长发育检查。同时,由于儿童在校出勤率低,教师没有太多机会发现孩子的语言问题。他们无法像生活在稳定家庭环境中的儿童那样接受由健康教育机构提供的语言监测服务。寄宿或寄养儿童的语言障碍未引起语言病理学专家的关注,因为对这些孩子的照顾通常涉及多个机构、专业人员和寄养家庭。人们普遍认为这样的多元关注将提高对这些孩子的关注度,加快语

① Palepu, A., Gadermann, A., Hubley, A. M., Farrell, S., Gogosis, E., AUBRY, T., & HWANG, S. W. "Substance use and access to health care and addiction treatment among homeless and vulnerably housed persons in three Canadian cities". *PLoS One*, 2013.

② Cummings, L. *Pragmatic disorders*. Cham, Switzerland: Springer, 2014.

③ Clark, A., Fitzsimons, D. "Unidentifed and unmet". *Bulletin*, 2016, 769: 16 - 17.



中国知网 https://www.cnki.net

言问题被识别的进程，但现实并非如此。尽管参与孩子照顾的机构和专业人员数量不断增加，但每个机构和专业人员都只专注于特定的责任范围，语言问题仍然面临着被忽略的风险。当各个机构与专业人员之间的沟通协调不畅时，这种风险尤其显著。要提高这些儿童语用障碍的识别率，语言病理学家必须与社会工作者以及其他参与照顾的专业人员建立更紧密的合作关系，并强调教育和培训在识别语用障碍中的重要性。

此外，还有一组特殊儿童患有语用障碍，但未得到语言病理专科治疗。他们之所以未接受临床语言治疗，并非因为社会原因（如边缘化或社会排斥）。研究发现，被跨国领养的儿童更有可能患语言障碍和语用障碍①。造成这种情况的原因并不难理解。一般而言，儿童的语用技能是在与父母或其他成年人的日常互动中逐渐发展的。然而，很多儿童在福利机构中生活若干年后才被正式跨国领养。他们被安置在照看人员不足的孤儿院等机构中，与成年人交流以及接受这类语言刺激的机会有限。这种环境可能会阻碍他们语用技能的正常发展，甚至导致语用障碍。当这些孩子最终被领养，他们需要适应新国家的文化，面临更大的风险和挑战。掌握新文化的语用规范并非易事，即便他们学会了，也可能并不全面。领养父母有时会将语用障碍误解为文化适应过程中的暂时性问题，从而忽略了孩子们的困扰，这进一步增加了问题的复杂性。近年来，越来越多的语言病理学家开始认识到跨国领养儿童的特殊需求和所面临的挑战。

## 五 临床语用学的发展之路

上述讨论的患者群体为临床语用学研究打开了一扇新的、更具包容性的大门。只有通过关注那些迄今被忽略的语用障碍患者群体，21 世纪临床语用学的重要性才能逐渐被广泛认识到。在未来几年内，临床语用学可以通过多种方式向临床医生和研究人员证明其重要性和价值，例如将临床语

① Petranovich, C. L., Walz, N. C., Staat, M. A., Chiu, C. P., Wade, S. L. "Structural language, pragmatic communication, behavior, and social competence in children adopted internationally: A pilot study". *Applied Neuropsychology. Child*, 2016, 23: 1 - 12. Rakhlin, N., Hein, S., Doyle, N., Hart, L., Macomber, D., Ruchkin, V., TAN, M., Grigorenko, E. L. "Language development of internationally adopted children: Adverse early experiences outweigh the age of acquisition effect". *Journal of Communication Disorders*, 2015, 57: 66 - 80.



中国知网 https://www.cnki.net

用学引入疾病分类学与医学诊断领域。从传统意义上看,这些领域与语用学没有直接关系,或者至少不像本文所设想的那样紧密相关。但笔者认为,临床语用学已经发展到一个新的阶段,在这个阶段中,它能够将其理论原理与思想应用到其他领域,从而展示出其独特的价值。在医学和其他领域中,研究者和临床医生面临着许多诊断挑战,而临床语用学正好能在这方面发挥重要作用。本节将简要介绍这种新应用,并在后续文章中进行详细阐述①。

长期以来,语言病理学家利用语用特征来诊断原发性语用障碍②,并将这些障碍与多种疾病交织叠加呈现的症状区分开来。以儿童语言障碍分类学中的一个长期存在的问题为例,那些具有良好结构性语言技能,但在上下文中使用语言遇到困难的儿童,一直给临床医生带来诊断上的挑战。他们与特定型语言障碍的儿童一样具有正常的非言语认知技能,在形态句法方面没有明显缺陷,而形态句法缺陷是特定型语言障碍儿童的典型特征。此外,他们语用障碍的症状在许多方面类似于孤独症谱系障碍的儿童,但没有表现出孤独症谱系障碍儿童所特有的局限兴趣、重复行为、刻板单一和感官知觉异常等行为。这个非同寻常的语用障碍群体被贴上了不同的标签,包括语义-语用障碍症、语用语言障碍症以及最近在第五版《精神障碍诊断和统计手册》(*Diagnostic and statistical manual of mental disorders*)(简称 DSM-5)③中被定义为社交沟通障碍症。对于临床医生而言,问题在于是否将这些语用障碍儿童患者归类为特定型语言障碍的亚组(即与语用语言障碍症有重合症状的特定型语言障碍),还是将其视为介于特定型语言障碍与孤独症谱系障碍之间的一种独立疾病。Gerenser④ 准确地描述了这一诊断困境:

---

① Cummings, L. "Establishing diagnostic criteria: The role of clinical pragmatics". *Lodz Papers in Pragmatics*, 2012,8(1):61-84.

② 句法、语义等语言结构有缺陷或认知系统缺陷均能导致患者的语用障碍。其中,因语言和(或)认知缺陷导致的语用能力受损称为继发性语用障碍症;无任何语言或认知缺陷的语用能力受损称为原发性语用障碍。

③ American Psychiatric Association. *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). American Psychiatric Association, 2013.

④ Gerenser, J. Language disorders in children with autism. In R. G. Schwartz (Ed.), *Handbook of child language disorders* (pp. 67-89). New York: Psychology Press, 2009.



中国知网 https://www.cnki.net

> “关于孤独症谱系障碍、语用语言障碍症和特定型语言障碍之间的关系，语用语言障碍症与孤独症之间的联系可能比语用语言障碍症与特定型语言障碍更紧密；语用语言障碍症可能是孤独症的一个亚组，通常被称为高功能孤独症。另一种观点是，一些患有语用语言障碍的儿童实际上可能介于特定型语言障碍和孤独症谱系障碍之间，这意味着他们同时具有特定型语言障碍和孤独症的某些特征，但又未达到孤独症谱系障碍的诊断标准(P74—P75)。”

临床语用学在诊断领域的贡献不可小觑，尤其当 DSM-5 首次将社交沟通障碍纳入诊断标准时，更凸显了其重要性。然而，笔者认为，语用学的作用远不止于此，它在疾病分类学与诊断中扮演着更为重要的角色。语用标准不仅能用于诊断语用语言障碍和社交沟通障碍是否为原发性障碍，还可用于评估精神、认知和行为障碍，例如注意力缺陷多动障碍、痴呆症和精神分裂症①。这种对语用学的新型诊断功能的认可源于多个因素。以下将介绍两个与精神分裂症有关的因素。

首先，目前用于诊断精神分裂症的 DSM-5 标准在本质上具有语用属性。失语症或语言贫乏是精神分裂症的阴性症状②之一。失语患者的言语量较少，话轮传递信息较为简略。他们未能满足听者的信息需求，违反了格莱斯准则中的数量准则，即说话人的话语信息不足。言语混乱或思维形式障碍是精神分裂症的阳性症状。在这种情况下，患者的话语缺乏指称连贯性，内容不相关且不合逻辑。这再次表明，言语混乱的特征与语用障碍症状

---

① Bambini, V., Arcara, G., Bechi, M., Buonocore, M., Cavallaro, R., Bosia, M. “The communicative impairment as a core feature of schizophrenia: Frequency of pragmatic deficit, cognitive substrates, and relation with quality of life”. *Comprehensive Psychiatry*, 2016, 71: 106 - 120. Pawełczyk, A., ŁOjek, E., Żurner, N., Gawłowska-sawosz, M., Pawełczyk, T. “Higher-order language dysfunctions as a possible neurolinguistic endophenotype for schizophrenia: Evidence from patients and their unaffected first-degree relatives”. *Psychiatry Research*, 2018, 267: 63 - 72.

② 精神分裂症的阴性症状表现为正常行为的缺失，例如失语、动机和情感缺失；而阳性症状则表现为异常行为的存在，如妄想(错误且古怪的信念)、幻觉(感知不存在的事物)和言语混乱。精神分裂症的确诊需要同时存在两种类型的症状。



中国知网 https://www.cnki.net

的相似性毋庸置疑。使用不相关的言语相当于违反了格莱斯准则中的关系准则,缺乏连贯性的言语往往不清楚、模糊且难以理解,这违反了格莱斯准则中的方式准则。

其次,精神分裂症的语用特征会随着病程和发展阶段而发生变化。在精神分裂症的第一次发作期和早期阶段,阳性症状最为突出。随着时间的推移,阳性症状往往会逐渐消退,并被阴性症状取代。因此,患有慢性精神分裂症的患者往往表现出更多的阴性症状,而阳性症状相对较少。由于精神分裂症的症状在一定程度上涉及语用行为,预计在患者身上可观察到更多的语用特征。例如,在早期阶段,患者可能表现出话语连贯性、相关性和一致性缺乏(即语言混乱)等特征;而在慢性阶段,患者则可能表现出话语量少、信息量不足(即失语症的特征)等特征。既往研究结果支持了这种语言特征的表现模式。Bearden[①]等人对105名青少年的言语样本进行了研究,其中54人被认为首次精神病发作的高危人群。在为期1年的随访中,研究者发现,与语言样本的基准相比,已发展为精神分裂症的青少年在实现语言连贯性时使用指称标记语的数量显著少于未转化为精神分裂症的青少年。Bowie[②]等人对220名患有慢性精神分裂症的老年患者进行了为期2.3年的研究。他们发现,随着时间推移,患者的话语量逐渐减少,但言语杂乱无章的状况并未加剧,表现相对稳定。Saavedra[③]研究了病程超过20年的偏执型精神分裂症患者。其中一组受试者长期居住在疗养院,他们的语言叙述连贯性已经退化到几乎消失的程度。

显然,如果语言的语用特征可以在除原发性语用障碍之外的其他疾病的诊断中发挥作用,那么它们同样适用于精神分裂症的病理学诊断。然而,要充分发挥这一作用,语用标准必须具备比单一疾病更广泛的诊断范围。

---

① Bearden, C. E., WU, K. N., Caplan, R., Cannon, T. D. "Thought disorder and communication deviance as predictors of outcome in youth at clinical high risk for psychosis". *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 2011,50(7):669-680.

② Bowie, C.R., Tsapelas, I., Friedman, J., Parrella, M., White, L., Harvey, P.D. "The longitudinal course of thought disorder in geriatric patients with chronic schizophrenia". *American Journal of Psychiatry*, 2005,162(4):793-795.

③ Saavedra, J. "Quantitative criteria of narrative coherence and complexity in persons with paranoid schizophrenia". *Journal of Nervous and Mental Disease*, 2010,198(5):349-355.



中国知网 https://www.cnki.net

初步研究表明，情况确实如此[①]。对于注意缺陷多动障碍患者的注意力不集中和多动冲动症状，也可以开展与精神分裂症类似的语用研究。注意缺陷多动障碍患者常常表现出多动冲动症状，例如无法等待说话者完成当前话轮就自己开启下一个话轮，或者在说话者还没有问完问题时，他（她）就会将答案脱口而出。在患有注意缺陷多动障碍的成人和儿童的对话中，这被视为语用异常现象。此外，将语用标准应用于痴呆症的诊断，尤其是在活体检测方面展现了令人兴奋的可能性。这一点尤其重要，因为痴呆症的病理学检查只能在患者死后进行，并且无法确定患者的病情类型。例如，阿尔茨海默病病理研究不仅揭示了导致阿尔茨海默病的原因，还解释了大约 19% 的原发性进行性失语症病例的致病机理。原发性进行性失语症是一种临床痴呆综合征，其特征是语言功能逐渐衰退，而其他认知功能相对保留。因此，语用行为标记很可能具有超越传统神经病理学的诊断价值。

一个紧迫的问题是：在不同类型的痴呆症中，哪些语用能力的损害可能充当诊断标志？首先可以肯定的是，在病情初期，无法仅凭单一语用能力缺陷将一种痴呆症与其他所有形式的痴呆症区分开来。例如，隐喻或讽喻的理解能力受损不太可能将阿尔茨海默病的患者与血管性痴呆或额颞叶痴呆的患者区分开。这是因为单一语用技能涉及多种神经和认知功能，很难将其用作分辨不同类型痴呆症的可靠方法[②]。然而，一系列语用能力障碍症状的组合似乎有可能区分不同类型的痴呆症。例如，指称衔接性弱、话语离题（包含大量无关信息）或习语理解力差等多种语用障碍症状的组合，可能有助于区分不同类型的痴呆症。在最近的两项研究中，研究人员分析了患有阿尔茨海默病和原发性进行性失语症的患者的话语[③]。他们发现两组患者

---

① Cummings, L. "Establishing diagnostic criteria: The role of clinical pragmatics". *Lodz Papers in Pragmatics*, 2012, 8(1): 61 - 84.

② Stemmer, B. "Neural aspects of pragmatic disorders". In L. Cummings (Ed.), *Research in clinical pragmatics, volume* 11, *Perspectives in pragmatics, philosophy & psychology* (pp. 561 - 585). Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2017.

③ Cummings, L. "Describing the Cookie Theft picture: Sources of breakdown in Alzheimer's dementia". *Pragmatics & Society*, 2019, 10(2): 151 - 174. Cummings, L. "Narrating the Cinderella story in adults with primary progressive aphasia". In A. Capone (Ed.), *Further advances in pragmatics. New paradigms* (Vol. 2, pp. 301 - 329). Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2019.



中国知网 https://www.cnki.net

的话语信息量都减少了,这是两组患者中唯一且最重要的语用异常标志,即说话者的话语未能满足听众的信息量需求。两组患者均有指称性衔接弱导致的信息表达困难,除此之外再无症状重叠。阿尔茨海默病患者的言语问题主要表现在词汇语义缺乏,而原发性进行性失语症患者的言语问题则是执行计划的困难。相关研究仍在继续中。

## 六 结语

本文回顾了临床语用学在其相对短暂的历史中所取得的成就,并展望了其未来的发展方向。为了实现进一步的突破,研究者认为临床语用学必须拓宽视野,将研究范围扩展到更广泛的患有语用障碍的儿童和成人群体。有些患者因复杂的心理问题、认知或行为障碍掩盖了他们的语用能力障碍,导致这些问题在传统的语言病理学评估中被忽视;还有的患者因为酒精或药物使用问题而遭受社会边缘化或排斥,难以获得必要的语言治疗服务。这些复杂且未得到充分诊治的患者同样有权获得相应的医疗服务。因此,确保这些患者能够接受到适当的诊断和治疗,将是临床语用学领域工作者未来面临的重要挑战。本文还讨论了临床语用学如何拓展其在疾病分类和诊断方面的应用,包括如何将语用特征应用到精神分裂症、注意力缺陷多动障碍和痴呆症等疾病的诊断过程中。



中国知网 https://www.cnki.net